

Matriz Operacional de Cardenas Visión para la Digitalización del Contact Center: Enfoque Boyacá, Colombia

El presente informe consolida y organiza la información operativa esencial de Cardenas Visión, centrada exclusivamente en sus operaciones dentro del departamento de Boyacá, Colombia. El objetivo es estructurar estos datos logísticos, clínicos y administrativos para facilitar su digitalización precisa y eficiente, especialmente en sistemas de gestión de contacto (Contact Center/LLM) que requieren protocolos de flujo específicos y manejo de excepciones.

I. Módulos de Información Geográfica y Logística de Sedes

Cardenas Visión mantiene una extensa presencia geográfica en Boyacá, con un modelo operativo que centraliza los servicios especializados en una sede principal dentro del departamento.

I.A. Sedes Operacionales de Cardenas Visión en Boyacá

La entidad dispone de seis sedes operacionales en Boyacá: Moniquirá, Chiquinquirá, Duitama, Sogamoso, Samacá, y Tunja.¹ Aunque la sede principal de la empresa se ubica en Acacías, la operación de Boyacá se estructura alrededor de Tunja.

El análisis de la distribución de servicios revela que Tunja emerge como el principal centro clínico (*hub*) dentro del departamento, dado que es la única sede con agendas específicas para cirugías, consultas de control post-quirúrgico, y concentra la rotación de la mayoría de los subespecialistas.¹ Esta concentración de recursos sugiere que las sedes periféricas

(Monquirá, Chiquinquirá, etc.) operan como puntos de remisión y de prestación de oftalmología general inicial, canalizando los casos complejos o que requieren subespecialidad hacia Tunja. Por lo tanto, cualquier protocolo de agendamiento digital debe incluir una ruta de escalamiento geográfico forzado hacia Tunja cuando la solicitud involucre subespecialidades o procedimientos quirúrgicos.

I.B. Canales de Acceso y Horarios de Atención

La operación del *contact center* se rige por un horario estándar de lunes a viernes, con una interrupción al mediodía. Este horario es crítico para establecer las ventanas de disponibilidad para el agendamiento y la gestión de PQRs (Peticiones, Quejas y Reclamos) y tutelas.¹

Table 1: Canales de Contacto y Horarios de Cardenas Visión

Medio de Contacto	Detalle (Número/Vía)	Horario de Atención	Propósito Específico
Vía Telefónica	Línea 333 033 32 52	Lunes a viernes, 8:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00	General (Citas, PQRs, Tutelas) ¹
WhatsApp	Número 316 751 5178	Lunes a viernes, 8:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00	General ¹
Correo Electrónico	N/A (vía correo)	Se atienden correos de pacientes, PQRs y tutelas.	Pacientes, PQRs, Tutelas ¹
Línea Alternativa (Pumaca)	Vía WhatsApp o telefónica	N/A (Horario no detallado)	Entidad Pumaca ¹

Programación de Cirugía	Línea especial y compañera dedicada	N/A (Horario/Número no detallado)	Programación de Cirugía ¹
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

II. Portafolio de Servicios Clínicos y Subespecialidades

Los servicios ofrecidos definen los flujos de trabajo en el *contact center* y se dividen en cuatro categorías operacionales principales: Oftalmología General, Citas con Subespecialistas, Agendamiento de Exámenes y Programación de Cirugía.¹

II.A. Servicios Ofrecidos

Los agentes gestionan el agendamiento de citas para la Oftalmología General y para las subespecialidades. Además, existe una gestión específica para la Programación de Cirugía, que cuenta con una línea y una compañera dedicada.¹ Esta segregación de la programación quirúrgica es fundamental y debe ser reflejada en el sistema digitalizado para asegurar que los usuarios sean dirigidos al canal adecuado.

II.B. Subespecialidades Disponibles y Frecuencia de Asistencia

La prestación de servicios especializados en Tunja se caracteriza por la baja frecuencia de asistencia de los profesionales, lo cual requiere una gestión proactiva de la demanda y el uso de listas de espera. La mayoría de las subespecialidades, como Glaucoma, Retina y Orto Óptica, tienen una asistencia programada de solo una vez al mes.¹

Esta baja frecuencia, que implica solo 12 días de disponibilidad al año por cada subespecialidad (o menos), genera un riesgo operacional en el cumplimiento de los estándares de Oportunidad exigidos por la Superintendencia Nacional de Salud. Este riesgo es particularmente alto en el caso de Estrabismo, donde la disponibilidad es aún más limitada.

Table 2: Subespecialidades Clínicas, Frecuencia y Condiciones de Tunja

Subespecialidad	Frecuencia de Asistencia	Condiciones Operacionales Clave
Glaucoma	Una vez al mes	N/A ¹
Retina	Una vez al mes	N/A ¹
Estrabismo	Una vez cada tres meses (Trimestral)	Se gestiona una lista de espera en Excel para estos pacientes. ¹
Orto Óptica	Una vez al mes	N/A ¹
Anestesia	Agenda habilitada con un mes de antelación	Dos especialistas (Dra. Mejía y Dr. Juan Humberto), crucial para cirugía. ¹
Corneología	No se atiende en Tunja	Remisión obligatoria a Bogotá. Requiere exámenes previos y autorización (si el paciente pertenece a Coosalud). ¹

La gestión del agendamiento para Estrabismo (a cargo de la Dra. Mónica Valero, quien asiste trimestralmente) debe integrarse con el proceso manual de lista de espera en Excel.¹ El sistema digital debe ser configurado para registrar inmediatamente la solicitud en esta lista si no hay disponibilidad trimestral, y debe informar al usuario de la baja frecuencia de asistencia.

III. Especialistas Clave y Rotación en Boyacá (Sede Tunja)

El Dr. Giovanni, quien es Oftalmólogo general y director científico de la empresa, es el eje central de la operación en Tunja. Su agenda estructura la capacidad quirúrgica y de control post-operatorio de la sede.¹

Table 3: Programación de Especialistas Clave en la Sede Tunja

Especialista	Rol/Subespecialidad	Actividad y Frecuencia en Tunja	Observaciones
Dr. Giovanni	Oftalmólogo General / Director Científico	Miércoles: Consulta y controles de cirugías. Martes: Realiza cirugías en la clínica.	Se traslada a las demás sedes el resto de los días. ¹
Dra. Paola	Especialista en la clínica	N/A (Frecuencia no especificada).	N/A ¹
Dra. Mónica Valero	Estrabismo	Asistencia una vez cada tres meses.	Trabaja en conjunto con la lista de espera de Excel. ¹
Dra. Mejía, Dr. Juan Humberto	Anestesia	Habilitan sus agendas con un mes de antelación.	Dos especialistas, esenciales para la operación quirúrgica. ¹

Existe una interdependencia crítica entre el Dr. Giovanni y los especialistas en Anestesia. El Dr. Giovanni realiza cirugías los martes en Tunja.¹ Para que estas cirugías se lleven a cabo, la agenda de los especialistas en Anestesia (Dra. Mejía y Dr. Juan Humberto) debe estar habilitada con un mes de antelación.¹ El módulo de Programación de Cirugía debe, por lo tanto, incluir un protocolo estricto de verificación cruzada que asegure la disponibilidad de Anestesia confirmada, enlazándola con la fecha quirúrgica del Dr. Giovanni. Un fallo en la coordinación de la agenda de Anestesia afecta directamente la capacidad quirúrgica semanal de la entidad.

IV. Logística Administrativa y Gestión de Convenios (EPS)

La entidad atiende a pacientes particulares y a usuarios de Entidades Promotoras de Salud (EPS) con convenios, priorizados según acuerdos contractuales.

IV.A. Entidades con Convenio (EPS) y Prioridades

Las prioridades en la gestión de citas son esenciales para asignar cupos de forma eficiente y gestionar el volumen de la demanda.

Table 4: Entidades con Convenio (EPS), Prioridad y Reglas de Autorización

Entidad (EPS)	Prioridad	Requisito de Autorización	Nota Contractual y Flujo Operacional
FUMARC	Prioridad 1	No se especifican reglas de excepción.	N/A ¹
Cajacopi	Prioridad 2	NO requiere autorización.	Contrato PGP (Presupuesto Global Prospectivo) con presupuesto mensual designado por agrupadores (imaginología, apoyo diagnóstico y cirugías). ¹

Famisanar	Prioridad 3	No se especifican reglas de excepción.	N/A ¹
Coosalud	Prioridad 4	Requiere autorización (ej. explícito para Corneología).	N/A ¹
Particulares	N/A	N/A	También se atienden. ¹

La exención de la autorización previa para los pacientes de Cajacopi (Prioridad 2) es la excepción administrativa más relevante. En un entorno donde la verificación de autorizaciones requiere el uso de cuatro plataformas específicas (una por cada entidad) y la gestión de múltiples estados, la eliminación de este paso para Cajacopi reduce drásticamente la fricción y el tiempo medio de manejo (AHT) del agente.¹ El sistema de agendamiento digital debe identificar la EPS de manera inmediata para saltar el flujo de verificación de autorización si el paciente pertenece a Cajacopi.

IV.B. Proceso de Agendamiento y Autorizaciones

La verificación precisa del estado de las autorizaciones es fundamental antes de asignar un servicio. Se utilizan cuatro plataformas, una por cada entidad, para este proceso. Además de verificar la autorización, el agente debe determinar si el usuario es contributivo o subsidiado y su nivel al editar el perfil en el sistema de gestión.¹

Los estados estándar de la autorización son:

1. **Radicada:** La solicitud ha sido generada, pero no puede ser utilizada para el agendamiento.
2. **Direccionada:** La autorización ha sido aceptada por la EPS. El tiempo estimado para que una solicitud pase de Radicada a Direccionada es de 5 días.
3. **Autorizada:** La autorización ya ha sido utilizada para la prestación del servicio.

En el proceso de agendamiento, es obligatorio registrar el medio por el cual se concretó la cita (ejemplo, vía correo electrónico, WhatsApp o telefónica) en las Notas de Agendamiento, lo cual es vital para la trazabilidad y la auditoría interna.¹

V. Protocolos Pre-Clínicos Obligatorios (Optometría y Exámenes)

Para las citas de Optometría y Exámenes Oftalmológicos, la función del agente se extiende más allá de lo administrativo, incluyendo la comunicación de protocolos pre-clínicos estrictos. Esta intervención es crítica para garantizar la validez y pertinencia del examen, minimizando la tasa de re-consultas por errores de preparación.¹

V.A. Requisitos de Preparación Previa Obligatoria

El protocolo de preparación se enfoca en el retiro obligatorio de lentes de contacto. El agente debe notificar claramente al paciente la instrucción de retiro, diferenciando por tipo de lente, y obtener la confirmación de entendimiento por parte del usuario.¹

Table 6: Protocolo Obligatorio de Retiro de Lentes de Contacto para Exámenes

Tipo de Lente de Contacto	Instrucción de Retiro	Tiempo Mínimo de Retiro	Justificación Clínica (Pertinencia)
Lente de Contacto Rígido (LC Rígido)	Retirar los lentes de contacto.	48 horas antes de la cita.	Permitir que la córnea recupere su curvatura natural. ¹
Lente de Contacto Blando (LC Blando)	Retirar los lentes de contacto.	24 horas antes de la cita.	Reducir la hidratación y alteración temporal de la superficie corneal. ¹

Si el paciente no sigue el protocolo de retiro (especialmente las 48 horas para LC Rígido o 24 horas para LC Blando), el examen oftalmológico puede resultar inválido, obligando a

reprogramar la cita y consumiendo recursos escasos del especialista. El sistema digital debe incorporar una pregunta obligatoria sobre el uso de lentes de contacto para cualquier agendamiento de Optometría/Exámenes, y la confirmación debe estar supeditada a la aceptación de estas instrucciones de preparación, registrando el acuerdo del usuario en las notas.¹

VI. Resumen Operacional de Alto Riesgo y Flujos de Excepción

La digitalización debe priorizar la correcta implementación de los flujos de excepción, ya que son los puntos de mayor complejidad operativa y riesgo de incumplimiento regulatorio.

VI.A. Flujo Excepcional para Corneología

La Corneología no es atendida en la sede de Tunja.¹ Esto impone una ruta de atención estrictamente definida:

- **Ruta Obligatoria:** Remisión a Bogotá para cita presencial.¹
- **Requisitos Pre-Remisión:** El agendamiento requiere que el paciente presente exámenes previos obligatorios (*Ventaja* y valoración por optometría con *enciclopedias*).¹
- **Autorización Específica:** Si el paciente pertenece a Coosalud (Prioridad 4), se requiere la autorización explícita de la EPS para la remisión y el servicio.¹ El sistema debe aplicar un filtro inmediato para los pacientes de Corneología, asegurando que se cumplan todos los requisitos de exámenes y autorización P4 antes de confirmar la remisión a Bogotá.

VI.B. Flujo Excepcional para Estrabismo

Debido a la baja frecuencia de la especialista (Dra. Mónica Valero) de solo una vez cada tres meses¹, la gestión de la demanda debe ser inmediatamente desviada a un protocolo de lista de espera para mitigar el riesgo de incumplimiento de oportunidad:

- **Ruta Obligatoria:** Gestión de la demanda a través de una **lista de espera en Excel**.¹
- **Acción del Agente:** Si no hay cupo disponible dentro del trimestre de la Dra. Valero, el sistema debe indicar al agente la necesidad de registrar los datos del paciente en la lista de espera de Excel y de comunicar al usuario el tiempo estimado de espera.

VI.C. Flujo Simplificado para Cajacopi (P2)

El agendamiento para pacientes de Cajacopi (Prioridad 2) representa una optimización operacional significativa:

- **Regla de Oro:** Se omite totalmente el proceso estándar de verificación de autorización (Radicada, Direccionada, Autorizada).¹
- **Justificación:** El contrato PGP cubre servicios como imaginología, apoyo diagnóstico y cirugías mediante un presupuesto global pre-acordado, eliminando la necesidad de trámites individuales de autorización.¹
- **Implicación para Digitización:** La identificación de Cajacopi como EPS debe ser el primer filtro en el flujo de agendamiento, permitiendo un salto directo a la asignación de cita, lo que acelera la atención y mejora la experiencia del usuario.

Obras citadas

1. Protocolos Call Center Salud Oftalmología-1.pdf